

Anexo 2022 al "PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN RELACIÓN CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON GRAVE AFECTACIÓN DE SU SALUD INCLUIDOS EN EL SISTEMA DE DATOS COMPARTIDOS"

Como parte integrante de la Mesa Intersectorial de Trabajo convocada desde la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional mejorar las prácticas y articulaciones intersectoriales para brindar una respuesta más efectiva de salud al grupo de niñas, niños y adolescentes incluidos en el protocolo suscrito en el año 2018 y, en función de las evaluaciones de proceso realizadas en la implementación y vigencia de dicho protocolo, la Subsecretaría de Atención Hospitalaria y la Dirección General de Salud Mental proponen algunas orientaciones de acción intersectorial para poner en consideración ante los demás organismos convocados y una serie de especificaciones de intervención propias del ámbito hospitalario.

Selección del Efector Sanitario: del listado de hospitales mencionados en el protocolo que realizan una cooperación especial a los que lo/as jóvenes que son acompañados por personal del CDNNyA o son trasladados por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) del Ministerio de Salud, independientemente de los radios asignados a las unidades del sistema, se reorganizarán de manera que queden georreferenciadas las acciones intersectoriales y la asistencia sanitaria en dos áreas de competencia:

Zona sur: Elizalde/Argerich (Áreas programáticas que engloba: Argerich, Penna, Piñero, Santojanni, Grierson)

Zona norte: Gutiérrez/Fernández (Áreas programáticas que engloba: Ramos Mejía, Durand, Álvarez, Vélez Sarsfield, Zubizarreta, Tornú, Fernández, Pirovano).

- 2) **Evaluación integral:** el ingreso del/la joven al hospital brindará, además de la evaluación y atención por Pediatría o Adolescencia -según corresponda- y el Equipo Interdisciplinario de Salud Mental de la guardia externa, una oportunidad para reestablecer vínculos de confianza e instancias de cuidado perdidas en su cotidianeidad.

Se detalla a continuación el proceso asistencial acordado con las autoridades de los departamentos de urgencia para guardia hospitalaria:

Recepción:

Al momento del ingreso del paciente al hospital es esencial, además de la consigna policial habitual y/o el recurso posterior del acompañamiento hospitalario, la presencia y permanencia de un referente social o institucional que conozca la situación del/la joven y con quien éste tenga un vínculo significativo de confianza para facilitar el proceso de admisión en el establecimiento sanitario y coordinar las acciones tendientes a lograr el consentimiento del/la joven a la asistencia brindada.

Permanencia:

Se establece como período mínimo de 24 a 72 hs la permanencia hospitalaria en el efector de urgencias para la evaluación integral de salud, la mitigación de posibles efectos de

desintoxicación u otras problemáticas de salud asociadas, y acordar las acciones intersectoriales subsiguientes para la continuidad asistencial.

Evaluación:

La **evaluación clínica** consistirá en los siguientes puntos:

- Interrogatorio de antecedentes personales y familiares.
- Examen físico
- Realización de test de laboratorio que incluya hemograma, química, medio interno y coagulograma. A modificar o ampliar en base a contextos o hallazgos.
- Screening de drogas en orina. (Hoja de Toxicología)
- ECG
- Radiografía de tórax
- Dependiendo la situación epidemiológica evaluar acciones. Por ejemplo, PCR para SARS CoV 2. Considerar test de embarazo. Evaluar pertinencia y consentimiento para estudios de HIV, PPD u otras enfermedades transmisibles.
- Acceso a la valoración multidisciplinaria, Salud Mental, Toxicología y demás especialidades que correspondan al caso.
- Registro de antecedentes de inmunización. Aprovechar la oportunidad para avanzar con el plan de vacunación, si es posible.

La **evaluación de salud mental** se desarrollará como parte del proceso asistencial integral, mediante una serie de entrevistas al joven y referentes sociales o institucionales durante el tiempo en que se desarrolle la intervención.

La evaluación por salud mental consistirá en los siguientes puntos:

Medidas iniciales de cuidado:

- Establecer las medidas básicas que deben acompañar todo el proceso de atención. Garantizar condiciones de seguridad, privacidad y cuidado.
- Disponer del tiempo necesario para la atención. Generar un vínculo de confianza con el/la joven y/o con sus acompañantes.
- Identificar a los referentes vinculares que pudieran resultar tranquilizadores y colaborar durante el proceso de atención. En caso contrario, deberán ser incluidos en momentos diferenciados. Considerar que los referentes vinculares también requieren la atención del equipo de salud.

Evaluación:

- Evaluación integral del estado de la persona y de la situación.
- Diagnóstico diferencial (patología orgánica, psíquica o intoxicaciones, entre otros). Considerar sintomatología médica concomitante y solicitar interconsultas correspondientes.
- Diagnóstico psicopatológico, valoración clínica global de la crisis.
- Evaluación del estado psíquico global:

Medidas de protección integral de niños, niñas y adolescentes:

- Coordinar las primeras medidas terapéuticas: abordaje psicosocial, psicoterapéutico, psicofarmacológico.

- Coordinar y acordar estrategia con la autoridad administrativa de protección de derechos del niño/adolescente correspondiente.
- Actores principales: Guardia Jurídica Permanente (CDNNyA), Defensorías Zonales (CDNNyA), Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (CDNNyA), Defensorías y Juzgados competentes.

Acciones Intersectoriales:

- Coordinar acciones de apoyo y continuidad de cuidados con los equipos socio-asistenciales intervinientes.
- Actores principales: Equipo ATENNA (CDNNyA), otros Equipos de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (CDNNyA).

Plan de Tratamiento:

- Evaluar los condicionamientos personales, sociales y de apoyo para sostener un tratamiento ambulatorio, centro de día o residencial especializado en adicciones.
- Evaluar el grado de conciencia de situación y enfermedad que pudieran condicionar su decisión y la viabilidad de abordajes ambulatorios.
- Evaluar estrategias de abordaje con la red socio-familiar.
- Evaluar criterios de internación.
- Actores principales: Red Integral de derivaciones en Salud Mental (DGSAM), Dirección General de Políticas Sociales en Adicciones (MDHyH).

Derivación:

En caso de presentar riesgo cierto e inminente se gestionará a través de la Red Integral de Derivaciones en Salud Mental el traslado correspondiente al hospital especializado.

En caso de no presentar riesgo cierto e inminente, el equipo de salud mental deberá acordar la mejor estrategia posible junto a los demás organismos de protección de derechos intervinientes y la Dirección General de Políticas Sociales en Adicciones, del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, GCBA.

Seguimiento longitudinal:

Se reafirma la disponibilidad del Equipo de Enlace en Salud Mental y Adicciones Infanto-Juvenil, recurso oportunamente otorgado por la Dirección General de Salud Mental para mejorar la articulación intersectorial de salud mental con las instituciones y organismos del Sistema de Promoción y Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, antes y después de los eventos de hospitalización, y para brindar estrategias de apoyo de salud mental en el seguimiento individualizado de lo/as jóvenes por los equipos socio-asistenciales del CDNNyA y del MDHyH.

Dra. LAURACORDERO
SUBSECRETARIA
Subsecretaría Atención Hospitalaria
Ministerio de Salud - G.C.A.B.A.

Julio Marcelo Lucini
Presidente

Dr. Horacio Rodríguez O'Connor
Director General
Dirección General de Salud Mental
MSGC- GCBA

Dra. ADRIANA M. BARCHUK
Directora General de Servicios de
(Atención Permanente
Consejo de los Derechos de

Mg. JESICA V. SUAREZ
Directora General
Dirección General de Políticas Sociales en Adicciones
Dirección General de Políticas Sociales, Familiar y Comunitaria
Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat

Nicolas Echarr
Director General
Dirección General de Responsabilidad Penal
Juvenil
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
G.C.B.A.

Dr. Horacio Rodríguez O'Connor
Director General
Dirección General de Salud Mental
MSGC- GCBA
Dra. LAURACORDERO
SUBSECRETARIA
Subsecretaría Atención Hospitalaria
Ministerio de Salud - G.C.A.B.A.
Nicolas Echarr
Director General
Dirección General de Responsabilidad Penal
Juvenil
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
G.C.B.A.